

לשון קשורה היא פרוצדורה לא נעימה < אך ההפסד של ההתמעמעות יכול לגרום נזק לחייה האימהית. זו לא אמת מוחלטת. יש מקרים שאנו משחררים את הלשון זה לא פותר את הבעיה < מבנה לסת. אייל בוצר, יעל דובסטר. (תל אביב) ג'יי רונן (חיפה) דרומי (באר שבע)

מהי לשון קשורה?

לשון קשורה או כפי שהיא נקראת באנגלית Tongue-tie הינה בעיה מולדת בה הרקמה המקשרת בין הלשון לבין רצפת הפה מגבילה את התנועה התקינה של הלשון. כתוצאה מכך מתקצר טווח התנועה של הלשון, ומיומנויות כמו יניקה, עלולות להיפגע. בלטינית יש המכנים לשון קשורה בשם Ankyloglossia שפירושה "לשון עגונה".

glossa - לשון

Anchyl - מהמילה קרס מעוגן לבסיס הפה

עד כמה שכיחה תופעת הלשון הקשורה?

- התופעה של לשון קשורה קלאסית נצפית בערך ב 3-5 מכל מאה תינוקות לאחר הלידה, כאשר בבנים היא מתרחשת פי שלוש מאשר בבתות.
- 33% מכלל הילודים נולדים עם לשון קשורה.
- העלייה בשכיחות ההנקה בשנים האחרונות והדגש המושם בצדק רב על חשיבותה הגדולה, העלו את בעיית הלשון הקשורה למודעות.
- עם עידן האינטרנט מספרן של התופעות המיוחסות ללשון קשורה עולה ללא ביסוס מדעי לכך

פרט להנקה אין תופעות מוכחות המצדיקות באופן מדעי רפואי טיפול בלשון קשורה בגיל הינקות. לא לגמרי נכון, הלשון יש לה מסוגלות למתוח את המיתר באמצעות הלשון. ייתכן ותייהיה בעיית דיקציה. אם לשון קשורה שוחררה < לא ידוע במה עוד זה היה יכול לפגוע. לכן לא ניתן באמת לדעת כי לא נעשה מחקרים בנושא.

לשון קשורה ובעיות שיניים:

- מספר מאמרים שפורסמו בנושא הצביעו על בעיות שינון (בעיה בשיני הילדים) שונות בילדים עם לשון קשורה.
- הבעיה נובעת עקב שאריות מזון שאינן מורחקות ע"י הלשון שתנועתה מוגבלת.
- חלק מהמחברים טענו שמסיבה זו יש לבצע התערבות מוקדמת לפתרון בעית הלשון הקשורה בעוד שחלק אחר טען שהתערבות זו אינה משנה דבר לגבי נושא זה ולכן ככל הנראה יש להתייחס לכל מקרה לגופו.

לשון קשורה ובעיות אכילה: (אצל פעוטות שתהליך האכילה לא התייצב)

- בחלק מהילדים הלשון הקשורה עלולה להביא לבעיה בשמירה על אכילה "נקיה". אוכל שנפול למהפה.
- הילדים מתקשים להסתדר עם הנעת המזון בתוך הפה ולכן נוטים יותר לאכילה "מבולגנת".
- בנוסף חלק מהילדים אינם יכולים ללקק את השפתיים ובעיה זו מובילה לאמצעי ניקוי חליפיים (כגון שרוולים).
- ברוב המקרים אין בעיה ממשית בבליעה עצמה, למרות שניתן למצוא בספרות תיאורים של בעיות מסוג זה, הן נדירות יחסית. מה בולעים ואיך בולעים (בליעה של חתיכות גדולות כי הלשון לא מצליחה לעשות נכון את הבולוס).

ללקק גלידה < בעייתי .



לשון קשורה ובעיות הגיה:

- יש להדגיש לשון קשורה אינה גורמת בהכרח לבעיית הגיה, בחלק מהמקרים אכן יש בעיה כזו אך בחלק גדול מהמקרים אין כל בעיה.
 - בחלק מהמקרים בעיית ההגיה חלה בזמן דיבור מהיר בלבד.
- בני נוער < נשיקה צרפתית, קשה נשיקה עם לשון בגלל לשון קשורה.

בדיקה מצד ההנקה

יכולת האם להמשיך ולייצר חלב בשילוב עם יכולת התינוק לינוק. כל עוד עובד התהליך האנדוקריני < ייצור החלב מונע מהתהליך ההורמונלי. במידה ויש לשון קשורה < התינוק אכן מתאמץ יותר לינוק < אך יש לו כמות מספקת (עולה במשקל) במעבר לשלב האוטוקריני, בה ניהול אספקת החלב בה ביחס ישר לגירוי השד < מתחילות להתגלות בעיות משמעותיות. התינוק מתאמץ על מנת להמשיך לינוק. יניקה לא מספקת ולא אפקטיבית כתוצאה האי תקינות הלשון גורמת לירידה באספקת החלב. חיבור-ניתוק חיבור-ניתוק. וחוסר נוחות מתחילה להגיע. או שמתקיימת שביתת הנקה או בעת חשיפה לבקבוק מהירות הזרימה < כשהוא היה עם לשון קשורה על השד הוא היה צריך ממש להתאמץ. כשהבקבוק נכנס < זרימה גבוהה ביחס ליניקה.

תינוקות שורדים 15-ג' בשבוע (יונקים, עושים מספיק קקי)
תינוקות משגשגים בין 200-300 ג' בשבוע

3 מדדים לאבחון לשון קשורה:

1. כאב בפטמות - אם כואב לה בשדיים. כאב אי אפשר לשאת.
2. חוסר שגשוג של תינוק עליה במשקל של תינוק (גם אם העליה לא מספיק טובה) < תוצר ישיר לפגיעה בכמויות החלב. (דו כיווני)
3. חזרה של דלקות וסתימות < התינוק מגרה אותה ולא מצליח לנקז אותה מספיק.

ייתכן ויגיעו אמהות ללא שלושת פרמטרים אלה, ועדיין יאובחן לשון קשורה.

אבחונים מהצד התינוקי:

- תופעה דמויי ריפלוקס < פליטות מוגברות מתרחש כאשר החלב נכנס ללוע וחלב נכנס מאוד מהר ונזרק החוצה.
- הרבה פעמים יאובחן כריפלוקס < אבל בעצם יש לו לשון קשורה. שחרור הלשון יביא לפסקת ה"ריפלוקס".
- תינוק שלא נותן צואה/ מספיק צואה < מקבלים כמות נמוכה פר יניקה.
- אי מעבר למוצקים בגיל 6 חודשים < הם לא מסוגלים לבלוע באופן תקין כתוצאה מפעילות לא תקינה של הלשון.

תזמון התרת לשון קשורה

עד גיל 4 חודשים עושים בלי בעיה < עיניין של כמה רגעים, ללא כאב חריג.
מ 4 חודשים עד שנה < פרוצדורה יותר מורכבת מבחינת כאב.
מעל גיל שנה < תלוי בסוג השלון יש צורך בהרדמה מקומית.

תזמון התרת הלשון משפיעה מאוד על ההנקה והמשך ההנקה.



פעולת לשון תקינה



להצמדה תקינה נדרשים:

1. פה פעור לרווחה.
2. הלשון שלוחה מעל החניכיים תחת הפטמה.
3. הפטמה צריכה להיות משוכה עמוק פנימה, יחד עם ההילה או חלק ממנה.



בהעדר אחת התכונות הללו, ההנקה עלולה להיות לא אפקטיבית.

האם עלולה לחוות:

- הנקות ממושכות
- כאבים בפטמות
- קושי בייצור חלב

התינוק עלול לחוות:

- צקצוקים ורעשים
- מציצות לא יעילות
- כאבי בטן וגזים



להנקה תקינה < לשון עם תנועתיות תקינה.



בלשון קשורה, הלשון משוכה לרצפת הפה ומגבילה את יכולת התנועתיות. < המובילה להצמדה לא יעילה.



בלשון קשורה קצה הלשון אינו מגיע לעיתים לקו החניכיים, מצב הגורם ללשון ללעוס את הפטמה.

כמו כן תנועתיות הלשון כלפי הפטמה מוגבלת < תיתכן השלכה על ייצור החלב.

פעולת שחרור הלשון עשויה לפתור זאת בפשטות.



אבחון וזיהוי

קיימים על פי הספרות שישה צעדים לזיהוי מצב של לשון קשורה:

1. כאשר הלשון משורבבת החוצה, הקצה נשאר מעוגן מאחורי הגשר האלבאולרי (Alveolar ridge) – מעבר קו החניכיים.
2. כאשר הלשון בזמן שרבוזה החוצה נראית בצורת לב או מחורצת בחריצים.
לשון תקינה היא עגולה בקידמה.
תינוקות עם לשון קשורה – יש פס באמצע הלשון
3. כאשר התינוק בוכה, הלשון נשארת מעוגנת ומהודקת אחורנית.
כשהתינוק בוכה, הלשון עולה ומתקרבת כמה שיכולה לחניכיים. בלשון קשורה הלשון לא מגיעה לקו החניכיים ונשארת מטה.
- כשהמיתר קצר < טווח התנועה מתקצר, הפה לא נפתח מספיק רחב. (ניסוי – לשים אצבע מתחת לסנטר> ולנסות לפתוח את הפה> קשה לפתוח).
4. כאשר אדם אחר אינו יכול למתוח את לשון התינוק באופן ידני. (לא עושים, מעבירים אצבע מצד אחד לצד שני)
5. כאשר הפרנולום קצר (פחות מסנטימטר אחד) ולא גמיש.
6. כאשר הלשון מחוברת קרוב לגשר האלבאולרי



Could It Be a Tie?

Super Sleuthing for Tongue/Lip Tie



1. lip blister/crease

2. lip accordion

3. lip tuck

4. lip tether

5. two-tone tongue

6. high palate

7. tongue dents

8. tongue curl/cup

9. frenulum pop

Not meant as a diagnostic tool

www.staciebingham.com

1. בועית הנקה
בועית אומרת שמהו בתהליך לא תקין. לרוב נובע מפעילות לא תקינה של הלשון.
יש בועיות הנקה לא עם אוברסופלי – מפצים את בוסט החלב באמצעות שפה עליונה.
מאמץ עם השפה על פעילות לא תקינה של הלשון – לשון קשורה יוצרות את הבועיות.
2. כאשר התינוק יונק הוא מכניס את השפה העליונה פנימה.
אומרים לאם לפתוח את השפה, ברוב הפעמים התינוק מתנתק < זה מפריע לו.
3. התינוק מחזיק את השפה התחתונה, משרבב את שתי השפתיים.
השפה העליונה בפנים והשפה התחתונה בחוץ.
4. המיתר הווקלי קשור. שחרור זה מאוד מדמם, מלא כלי דם.
המיתר לא נקשר שוב (בשונה מהלשון מטה)
5. פלאק על הלשון, לרוב יחשב כמו פטריה אצל אדם לא בקיא מספיק.
ממש רואים נקודות. לא באופן מלא על כל הלשון.
פטריה היא על כל הלשון < מעיין דשא.
6. חך גבוה – רוב התינוקות עם לשון קשורה בעלי חך גבוה.
בשלב האמביאוטי הם לחצו על החך העליון < והוא מלכתחילה יותר גבוה.
7. הלשון לא מצליחה לזוז בתוך המרחב.
לא עולה מעלה ולא יוצאת מחלל הפה.
על השפתיים יש לו בלוטות על השפתיים כתוצאה מהפעלת לחץ על השפתיים.
8. חוסר יכולת להוציא לשון מעבר לקו החניכיים.
9. מיתר קצר < בלוטות הרוק עולות כלפי מעלה.

תנועת הלשון במהלך ביניקה

התארכות extension - לפיתה ומשיכה של השד במהלך החיפוש האוראלי.
תצורה configuration - יוצר מבנה תעלה על מנת לייצב את השד.

סימן ראשון הוא הוצאת לשון כחלק מסימני הרעב < הוצאת לשון בצורת cupping כמובנות לכניסת השד לחלל הפה.

במצבים של לשון קשורה

- יניקה שטוחה - לשון לא זזה או זזה לא כמו שצריך. מכה על רקמת השד.
- אין extension - אין התארכות של הלשון - התינוק לא מוציא מעבר לקו החניכיים.
- אין cupping - הלשון לא מתעגלת
- קושי ביניקה וקשי להישאר על השד - התנתקויות חוזרות ונשנות (לעלות במדרגות בנעלי ספרוט קשורות זו לזו < כלל שהזמן נמשך המוטיבציה יורדת)
- זמן האכלה ארוך, התעייפות התינוק – הרדמות התינוק על השד.



הנקה היא דיאדה, יש צורך להתחשב בצד האימהי - תינוק שגר על השד לעיתים מפצה, אוכל כל פעם קצת, עולה במשקל באופן תקין אבל נמצא על השד המון המון זמן.

- אין grooving – היכולת של התינוק להזיז את הלשון מצד לצד. משפיע מאוד על מעבר למוצקים (לא מצליח לעשות בולוס, ובולע את המזון) - המצריך לעיסה - בולע חתיכות, יורק החוצה > קשה לו מאוד במעבר ממעבר משחתי למוצק).
- קושי ביכולת להשתלט על חלב -
- ריפלוקס (כניסת הרבה חלב ומבלבל את התינוק) - במקום שהחלב יזלוג מטה עולה מעלה.
- פליטה מהאף – בזמן יניקה זולג חלב מהאף.
- תינוק יונק וזולג לו חלב מהצדדים. (הרבה חלב והוא לא מסתדר, יכול להעיד גם על אוברסופליי)
- אספרציות - בליעת נוזל לתוך קני הנשימה.
- בשינה בלילה > חלב עולה > הסוגר שאמור למנוע עליית מזון לקני הנשימה > נחנקים באמצע הלילה.

חוסר יכולת להוציא את הלשון Restricted extension

הוצאת הלשון מחוץ לקו החניכים הכרחית בזמן היניקה זאת על מנת למנוע מצב של הפעלת רפלקס הנשיכה



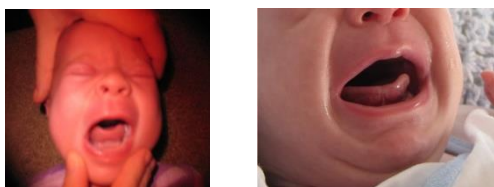
Restricted elevation

היכולת להניע את הלשון כלפי מעלה – היכולת הזו נבחנת כאשר התינוק בוכה הוא אמור להרים את הלשון ולנגוע בחיך כאשר הפה חצי פתוח. כאשר תינוק בוכה והלשון של שטוחה או עם הרמה חלקית



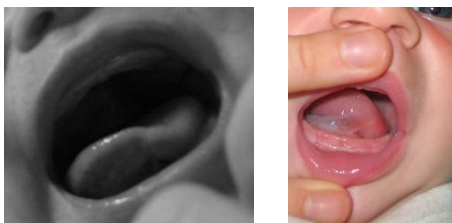
grooving/Cupping

- צידי הלשון אמורים לעלות בצורת תעלה ובכך להקיף את הפטמה לייצבה בפה ולסייע לבליעה
- אצל ילדים עם לשון שקורה יש מצבים שהמיתר מספיק אלסטי המאפשר את ה grooving

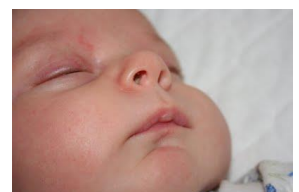


Lateralization

- היכולת להניע את הלשון מצד לצד
- יותר חשוב באכילת מזון מוצק מאפשר מעבר מזון למרכז הלשון ומנקה את חלל הפה



בועית הנקה





הערכת תנועתיות הלשון

הדרך הטובה ביותר להערכת התנועתיות היא באמצעות מציצה על האצבע.
כאשר יש נוזל יש תינוקת שיונקים באופן טוב ואפקטיבי

- Craved tip syringes

השפעה שלילית על הנקה



דרכים להגדיר את רקמת הלשון על פי בטיקורליוס

	0	1	2
What does the tongue-tip look like?			
Where it is fixed to the gum?			
How high can it lift (wide open mouth)?			
How far can it stick out?			

מחפשים איך ניראת הלשון	0
לגמרי קשורה.	1
חצי לב.	2
לגמריי שטוחה.	
כמה המיתר גמיש	0
לא זז בכלל – לא יאפשר ללשון כלל לעלות.	1
קשור מטה באופן מלא ולא מאפשר תזוזה	2
קשור חלקי	
האם התינוק מסוגל להעלות לשון מעבר לקו החניכיים.	0
לא מסוגלת כלל לעלות	1
עולה רק בצדדים אבל לא מצליחה להגיע לחך העליון	2
מצליחה לעלות אך לא מגיעה לחך העליון	
יכולת הוצאת הלשון מעבר לקו החניכיים	0
עוברת באופן מלא	1
לשון יוצאת עד קו החניכיים באופן חלקי	2
עוברת לגמריי	



סוגי לשון קשורה



Type 1 - סוגר את קצה הלשון. מחובר למכתש השיניים בד"כ דק, יכול להיות אלסטי. קשורה לחך עצמו - המיתר על הקצה של החניכיים (אפה שאמורות להיות השיניים)

פטמת סיליקון לסייע בחיבור עד שחרור הלשון. עם הדרכה מאוד מדויקת לשימור אספקת החלב. לעזור לשרוד ימים עד שחרור הלשון. אחרי יניקה מפטמת סיליקון < חייב שאיבה > לשמור על אספקת חלב. גם לשון קשורה וגם פטמת סיליקון עלולות לעשות סתימה – לכן תמיד לשלב שאיבה בסוף ההנקה.

יהיו השלכות בוודאות על הנקה אם לא ישוחרר הלשון. זה מאובחן כפתולוגיה, עלול לגרום להפרעות נשימה.



Type 2 - 2 עד 4 מ"מ מאחורי הלשון מיד מאחורי מכתש השיניים בד"כ דק ויכול להיות אלסטי. לא קשורה לקצה הלשון אך רואים שהיא קשורה קרוב לקו החניכיים. כל החלק האחורי מכוסה שכבת עור.

אייל בוצר – רופא שיניים שמתמחה בפה ולסת - יודע לאבחן כך ולשחרר את המיתר עמוק יותר, כך שהלשון משתחררת

רופא אף אוזן גרון – לא מספיק מומחים בנושא ולעיתים פותחים חצי דרך, המיתר נקשר לאחר שמתאחה ועושה צלקת. במקום לשפר את התהליך יוצרים את הפעולה ההפוכה. לאם לאחר "שחרור" כואב עוד יותר.



Type 3 - מחבר את מרכז הלשון באמצע החך התחתון בדרך כלל עבה, לא אלסטי, יותר סיבי.



Type 4 submucosal – לשון קשורה אחורית / לשון קשורה תת-רירית - הגיד עלול להתחבר מאחורי הרירית.



רקמה תת רירית מחברת את בסיס הלשון לקצה החך, בדרך כלל עבה, סיבי, בוהק ולא אלסטי. במקום שהמיתר יושב במרכז הלשון, הוא יושב בחלק האחורי של הלשון, קרוב למרכז הלוע. הלשון יוצאת החוצה, ועולה למעלה, ועושה grooving אבל כשנמצא בחלל הפה – יש חך גבוה דוחפת כלפי מעלה את החך, המיתר רחוק מהבוכנה (מנוף גדול מידי).

בשחרור נוצרת צלקת בדיוק במרכז, האיחוי מסדר את הלשון הלשונית וראו גדולים < הלשון יושבת עמו גל ונראת עבה. הפטמה נקלעת ברקמת שד בחך גבוה < כואב וצובט. עם השחרור הלשון משטתחת.

מאוד קשה לאבחן לשון מסוג זה, יש צורך במומחיות. לא כולם נוטים לטפל בזה.



הלשון הינו שריר יחידי שמחובר בצד אחד, בכדי שלא תברח בחלל הפה היא מקובעת ע"י מיתר, שצריך לשבת במחצית הדרך (בין החלק החיצוני לפנימי) , בכדי למנוע שהיא תגלוש פנימה ותחסום את דרכי הנשימה או לחילופין שלא תגלוש החוצה. סוג 1,2,3 – המיתר בחלק הקידמי, סוג 4 – בחלק האחורי. 1 – המיתר במקום לשבת במחצית הדרך, יושב על קצה הלשון 2 – קצת קרוב לקצה אך לא על הקצה מספיק רחוק מהמרכז אך מספיק קרוב לקצה 3 – בדיוק במעבר בין מרכז הלשון לקצת יותר קרוב לקצה שלה. (מסוגל להוציא לשון מעבר לקו החניכיים). 4 – המיתר יושב אחורה, במקום שישב במרכז הלשון, יושב בחלק האחורי של הלשון, קרוב למרכז הלוע.

1,2 כמעט כולם יודעים לאבחן. כשלא יודעים לאבחן זה לרוב 3,4.





לשון מחופה

הכי קשה לאבחן לשון מסוג זה מאחר והתינוק בכלל לא מצליח להרים את הלשון מבסיס הפה התינוק בד"כ יחזיק את הלשון מאחורי החניכיים הלשון תראה שטוחה . type2

החלק האחורי מחופה בשכבה לבנה, לא מצליח להרים את הלשון מעבר לקו החניכיים



תינוק מרים רק את השוליים, אך הלשון לא עולה - כמו מגדל אייפל, החלק האחורי מחופה בשכבה לבנה.

בלוטות הרוק עולות מעלה < המיתר מאוד קצר. בלוטות הרוק נמשכות מעלה



טיפול

המטרה שחרור של העגינה

- שיפור תנועתיות
- פתיחת הפה
- הרמת הלשון
- ניתוק המיתר עם מספרים
- אין צורך בהרדמה או טשטוש
- אין צורך במכשירי עזר/לייזר/תפירה



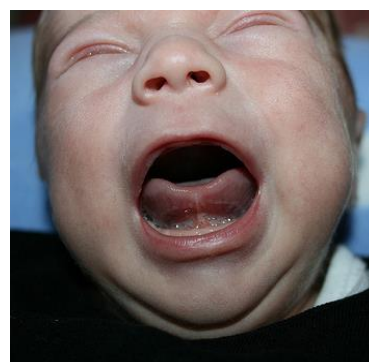
ניתוק בוכה> מרים יותר גבוה את הלשון ורואים את אורכו של המיתר> וניתן לראות עד כמה עמוק ניתן לחתוך את המיתר. לאחר החיתוך ולחצים לו את הלשון עם בד גזה להפסקת הדימום.

סביר מאוד להניח שיהיו שאריות דם בהנקה על הציצי של האם. זהו איזור עם המון כלי דם, מתנהג כמו צחצוח מהיר של שיניים שהדימום ממשיך.



לפני/אחרי

הלשון השתפרה, אך עדיין רואים שיש מיתר נשאר. יכול מאוד להיות שיצטרכו לעשות סיבוב שני של התרה.



אמהות לא מניקות

התינוק לא מצליח לייצב את הבקבוק בפה,
לא מצליחים לייצב את הבקבוק בפה > זולג חלב מהצד.
תינוקות לא מצליחים להעביר חלב.

סיבוכים

- דימום חזק
- הצטלקות
- דימום קל



שפה עליונה קשורה - פרנילום עליון

מצב שבוא השפה העליונה אינה עוטפת ביעילות את השד, מצב המפריע לשפתיים לשמר את הפטמה להתבסס בתוך הפה



פרוצדורה של שחרור שפה עליונה קשורה עשויה ביתר קלות לפתור את ההנקה הלא יעילה.



טיפול לאחר התרת הלשון

מכשיר פלסטי ששמים על האצבע > פיתוח ישראלי.
יש מכשיר שנקרא לייפר.
שעוזר לעודד את האלסטיות של המיתר.

יש תינוקות שהלשון שלהן מספיק אלסטית אם נעבוד עם הלייפר > כול להיות שנמתח מספיק את המיתר ולא נצטרך לשחרר את הלשון. Type4

לילי עוזיאל – במחקר. יועצת הנקה.

עיסוי הלשון

- תינוקות עם לשון קשורה מתקשים לפעמים להוריד את הלשון כלפי מטה
- גירוי קצה הלשון עם האצבע יכול לסייע להם להוריד את הלשון
- כדאי לעשות זאת תוך כדאי הנקה
- לגרות את השפתיים על מנת לעודד פתיחה
- החלקי את האצבע לתוך הפה לאורך החך
- אפשרי לתינוק למצוץ מס שניות
- משכי את האצבע כאשר יש עדין וואקום
- הורדי את הלשון כלפי מטה



עידוד הוצאת הלשון

אחרי שחרור לשון אנו עושים תרגול להכניס אמצע מתחת לרקמת הלשון ולהעבירה מצד לצד > שהמיתר לא התאחה באותו המקום.

- לגרות את השפה התחתונה
- להעביר את האצבע מצד לצד על החך התחתון





